

	Mapa de Processos: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Código: tag_ds_codigo_end
	Dono do Processo: Coordenador(a) do laboratório	Versão: tag_ds-versao_end
	Início do Processo: Recebimento da solicitação de exame via sistema MV.	
	Fim do Processo: Registro e liberação dos resultados dos exames pelo sistema MV e MatrixNet	

FORNECEDORES	ENTRADA	PRINCIPAIS ATIVIDADES	PRODUTOS	CLIENTES
Médicos	Solicitação de exames via sistema MV, amostra de líquidos corporais	1) Recebimento e análise das solicitações de exames 2) Classificação da urgência dos exames 3) Coleta da amostra pela equipe do laboratório com conferência de identificação e registro no sistema 4) Transporte em maleta até o laboratório e triagem com registro da entrada e separação por setor 5) Recebimento e conferência de amostras não coletadas pelo laboratório 6) Processamento técnico dos exames nos setores específicos 7) Validação Técnica e liberação Clínica dos Resultados	Resultados de exames	Equipe Assistencial, SPCIRAS, Medicina do Trabalho, Paciente
Enfermagem e Pacientes	Amostras biológicas devidamente identificadas		Comunicação de resultados críticos	Médicos e Enfermeiros
TI	Sistema MV e Matrix		Ordem de Serviço	Engenharia Clínica Engenharia Predial TI
Almoxarifado	Material de escritório, reagentes, insumos para coleta de material biológico		Solicitação de insumos para exames e materiais de escritório	Almoxarifado
Laboratórios Terceirizados	Resultados de exames externos		Solicitação de exames externos e amostras biológicas	Laboratórios Terceirizados
Gerentes e Coordenadores Médicos	Aprovações para exames de alto custo e não padronizados		Informações para avaliação de aquisição de exames de alto custo	Gerentes e Coordenadores Médicos
Farmácia	Saneantes, clorexidina, hipoclorito de sódio, quaternário de amônio, álcool 70%, água destilada, soro fisiológico.		Solicitação de saneantes, clorexidina, hipoclorito de sódio, quaternário de amônio, álcool 70%, água destilada, soro fisiológico.	Farmácia
Engenharia Clínica	Cronograma de manutenções preventivas e laudos		Frascos para coleta de exames e swab's	Enfermagem

Higienização e Limpeza	Coleta de resíduos, Limpeza terminal e concorrente	8) Disponibilização dos Laudos nos Sistemas 9) Registros, arquivamento dos exames realizados e armazenamento de amostras	Resultados parciais de cultura microbiológica	SPCIRAS
Medicina do Trabalho	Solicitação de exames periódicos e acompanhamento sorológico de acidente de trabalho com material biológico		Pedido de coleta de amostras de sangues	Equipe de Enfermagem da Neonatologia e Centro Cirúrgico
Segurança do Trabalho	EPI			
NUVEH	Solicitação de exames para controle epidemiológico			

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

- 1) Recebimento e análise das solicitações de exames:** A atividade começa com o médico fazendo os pedidos no sistema MV, que são automaticamente integrados ao Matrix utilizado no laboratório. Existem pedidos de rotina, agendados para horários específicos, e de urgência, para coleta imediata.
- 2) Classificação da urgência dos exames:** No Matrix, o exame é classificado como rotina, que segue horários programados, ou urgência, que exige coleta imediata. Essa triagem organiza o fluxo de coleta e processamento, priorizando a criticidade dos exames. Ela é fundamental para garantir o atendimento adequado às demandas do hospital.
- 3) Coleta da amostra pela equipe do laboratório com conferência de identificação e registro no sistema:** Para amostras de sangue, técnicos do laboratório se deslocam até os andares utilizando carrinhos equipados com computadores e impressoras de etiquetas. Já no pronto-socorro existe uma sala de coleta que o paciente pode se deslocar até ela ou o técnico, já com a etiqueta impressa e utilizando maleta, vai até o leito do paciente. As coletas são organizadas por prioridade. No momento da coleta, é obrigatória a conferência da pulseira de identificação do paciente. O horário da coleta é registrado no sistema Matrix. Quando a coleta não é realizada, o motivo é registrado como MPP (Motivo para Procedimento Pendente). Os carrinhos de coleta móveis, presentes em cada andar e equipados com computador possuem todos os materiais necessários para a coleta (agulhas, seringas, tubos variados). Os técnicos de plantão são responsáveis pela reposição diária desses materiais, conforme a demanda. O técnico também realiza a coleta de swabs nasais em pacientes do pronto socorro não internados. Pacientes internados no CTI com PIA (acesso arterial), os técnicos se deslocam até o leito e solicitam à equipe de enfermagem que realize a coleta de sangue.
- 4) Transporte em maleta até o laboratório e triagem com registro da entrada e separação por setor:** Após realizar as coletas, as amostras são acondicionadas em maletas e transportadas manualmente até o laboratório. Não se utiliza o carrinho de coleta nesse transporte. O tempo entre a coleta e a chegada é monitorado em decorrência da estabilidade da amostra. Ao chegar no laboratório, as amostras são conferidas pelo triagista, que registra a entrada no sistema com horário da entrada no laboratório. São separadas por setor, como Bioquímica, Hematologia e Microbiologia. Algumas, como as de coagulação, passam por centrifugação nesse momento. Amostras urgentes têm prioridade imediata na triagem e distribuição.
- 5) Recebimento e conferência de amostras não coletadas pelo laboratório:** Amostras de líquidos corporais (líquor, líquido pleural, ascítico, sinovial, pericárdico, etc) e biópsias são coletadas pelos médicos; pelos enfermeiros é coletado urina, fezes, swabs e escarro; as amostras de aspirados traqueais são coletadas pela equipe

de fisioterapia, médicos e enfermeiros; o paciente pode realizar a coleta de urina. No Centro Cirúrgico, Ambulatório de Controle de RNI e Neonatologia a coleta de material biológico é realizada pela equipe do setor. As amostras são levadas ao laboratório por quem coleta ou pela equipe de enfermagem.

- 6) Processamento técnico dos exames nos setores específicos:** As amostras são avaliadas quanto ao aspecto e volume; as adequadas são processadas com o uso de equipamentos automatizados ou, em alguns casos, por análise manual de acordo com o tipo de exame necessário. Para amostras inadequadas é solicitado recoleta. Os exames são distribuídos conforme o setor especializado. O laboratório dispõe de equipamentos de backup (máquinas reservas) para garantir a continuidade dos exames. São realizados controles internos diários e controles externos periódicos. Os equipamentos operam com reagentes específicos e demandam manutenções preventivas programadas. Exames específicos são realizados por empresas terceirizadas.
- 7) Validação Técnica e liberação Clínica dos Resultados:** O técnico realiza a validação técnica (conferência do aspecto das amostras e dos parâmetros laboratoriais), garantindo que o exame foi bem executado. Depois, o analista faz a validação clínica (análise e interpretação conforme histórico e dados clínicos), conferindo coerência com o prontuário, histórico e exames anteriores. Resultados críticos ou incoerentes geram investigação antes da liberação. O sistema possui alertas e bloqueios que evitam erros na liberação dos resultados.
- 8) Disponibilização dos Laudos nos Sistemas:** Após liberação clínica, os laudos são disponibilizados no sistema laboratorial Matrix e/ou MV para acesso pelo corpo clínico. Para os pacientes é disponibilizado acesso pelo MatrixNet com login e senha. Em situações de urgência, para agilizar o acesso à informação, a equipe do laboratório pode imprimir o resultado diretamente do equipamento e entregar para a enfermagem ou levar para o setor. Resultados considerados críticos são comunicados por telefone de acordo com o fluxo definido com os setores.
- 9) Registros, arquivamento dos exames realizados e armazenamento de amostras:** Dados brutos dos equipamentos são armazenados por cinco anos. As amostras são armazenadas em geladeiras por períodos específicos (ex: 7 dias para a maioria, 3 dias para microbiologia), visando possibilitar futuras investigações, reanálises ou verificação da qualidade da amostra, caso haja questionamentos sobre os resultados. Para testes rápidos, citologia e citometria, grupo sanguíneo há também um registro manual complementar ao sistema.

PRINCIPAIS PROBLEMAS

- **Grande dificuldade de localização dos pacientes:** Inexistência de leitos fixos no Pronto Socorro e principalmente no Sistema MV, dificultado, e muito, a localização do paciente.
- **Gargalo no transporte das amostras:** A demora entre a coleta da amostra nos andares e a chegada ao laboratório principalmente devido acúmulo de pedidos, compromete a estabilidade da amostra, especialmente em exames sensíveis como gasometria e coagulação.
- **Recoletas frequentes por falhas na coleta:** Amostras hemolisadas, insuficientes ou impróprias exigem nova coleta aumentam o retrabalho e atrasam o diagnóstico.
- **Identificação inadequada de pacientes:** A ausência ou falha na pulseira de identificação do paciente impede a coleta, gerando atrasos. Há risco de erro na conferência manual de nome e data de nascimento.
- **Impossibilidade de utilização do carrinho de coleta no Pronto Socorro:** a estrutura física atual do Pronto Socorro não permite o trânsito do carrinho nos corredores e unidades de internação alocadas no Pronto Socorro, além disso não é estimulado pelas equipes assistenciais que aqueles pacientes sem dificuldades de deambulação possam se dirigir ao posto de coleta.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO
1-8) TAT Geral 1-3) TAT Pré Analítico 3) Índice de contaminação de hemocultura 3 e 5) Recoleta Geral 5) Índice de contaminação de urocultura 6) TAT Analítico 7) TAT Pós Analítico, Insucesso na comunicação de resultados críticos, Laudos incorretos	1) POP.LAB.PRE.002;

Grau de Padronização do Processo				
Durante a execução deste processo, seguimos um ciclo de etapas/atividades bem regulado/estabelecido.				
() Concordo plenamente	() Concordo	(X) Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
Este processo é organizado de forma eficiente.				
() Concordo plenamente	() Concordo	(X) Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
A execução deste processo é altamente padronizada.				
() Concordo plenamente	(X) Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
Em grande parte, documentamos todas as ações realizadas neste processo.				
() Concordo plenamente	(X) Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente